

MINI PRAXIA

GRUPO 2 · 2 INTEGRANTES

Reto práctico para identificar fortalezas reales antes de asignar roles en el proyecto

1. Contexto mínimo

Praxia es una solución digital para la operación de consultorios. En este reto no se evaluará conocimiento médico ni una integración real con Meta/WhatsApp. Se evaluará la capacidad del equipo para construir un flujo web coherente de punta a punta, separando frontend, backend, datos e integración.

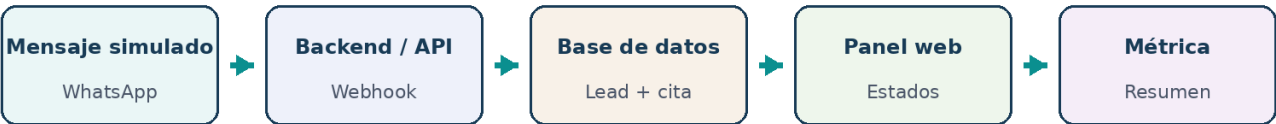
Objetivo del reto: demostrar que el equipo puede convertir un flujo de negocio en una aplicación funcional, entendible y mantenible. No buscamos un diseño perfecto; buscamos criterio técnico, integración y capacidad de explicación.

2. Tiempo y herramientas

Regla	Condición
Duración	8 horas efectivas, en una sola jornada.
IA	Permitida. Pueden usar ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot u otras herramientas.
Frameworks	Libres. El equipo elige stack y justifica la elección.
APIs reales	No son necesarias. WhatsApp debe simularse mediante un endpoint o evento ficticio.
Datos	Ficticios. No usar información real de pacientes.
Entrega	Aplicación ejecutable + repositorio/código + demo + explicación individual.

3. Flujo mínimo obligatorio

MINI PRAXIA - FLUJO MÍNIMO ESPERADO



- Registrar un lead/paciente ficticio.
- Recibir un “mensaje de WhatsApp” simulado a través de un endpoint, webhook ficticio o botón de prueba.
- Crear una cita asociada al lead.
- Cambiar el estado de la cita: pendiente, confirmada, cancelada y/o reprogramada.
- Mostrar un panel con citas de hoy, pendientes, confirmadas, canceladas y total de leads.
- Persistir los datos en una base de datos o almacenamiento estructurado.
- Mostrar al menos un caso de error o validación: campo obligatorio, cita duplicada, horario inválido o mensaje repetido.

4. Alcance visual esperado

No se entrega un diseño para copiar. El equipo debe proponer su propia interfaz. Como mínimo, la demo debe incluir:

- Vista de “Hoy” o Dashboard.
- Listado de leads/pacientes ficticios.
- Listado o agenda de citas.
- Formulario para crear/editar cita.
- Vista o componente que muestre el evento/mensaje simulado.
- Estados claros y legibles.

5. Qué NO se pide

- No conectar Meta Cloud API real.
- No implementar IA conversacional real.
- No hacer historia clínica.
- No implementar pagos ni facturación.
- No hacer microservicios, Kubernetes ni infraestructura compleja.
- No usar datos reales de pacientes.

6. Entrega y demostración

- Demo funcional de 5 a 10 minutos.
- Mostrar el flujo completo: mensaje simulado → lead → cita → cambio de estado → panel.
- Explicar stack, estructura y decisiones principales.
- Cada integrante debe explicar exactamente qué hizo personalmente.
- El equipo debe poder hacer una modificación pequeña en vivo si se solicita.

7. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Funciona de punta a punta	30%
Claridad del código y estructura	20%

Separación frontend/backend/datos	15%
Manejo de errores y validaciones	15%
Capacidad de explicar y modificar	15%
Presentación y orden	5%

La evaluación final será auditada por el ingeniero de sistemas. Durante las 8 horas no dará soluciones ni corregirá el código; la auditoría se realiza al cierre.

8. Organización del Grupo 2

El grupo debe separar claramente responsabilidades. Ambos comparten la responsabilidad de integrar y probar el resultado final.

Responsabilidad	Alcance principal
Backend	API, reglas, persistencia, citas, estados y validaciones del servidor.
Frontend	Interfaz, formularios, dashboard, consumo de API y experiencia de usuario.
Integración / Calidad	Responsabilidad compartida: ambos deben probar el flujo completo y corregir la integración entre sus partes.

Pueden apoyarse mutuamente y usar IA, pero cada integrante debe poder demostrar cuál fue su parte principal y explicar cómo se integra con la del compañero.

9. Evidencia individual obligatoria

- Nombre del integrante y rol asumido.
- Qué componentes o archivos trabajó principalmente.
- Qué decisión técnica tomó personalmente.
- Qué problema encontró y cómo lo resolvió.
- Qué mejoraría si tuviera un día adicional.